

ديناميكا البول مجموعة فحوصات تقيس مدى كفاءة المثانة في تخزين البول وإفراغه. تُستخدم أنابيب رفيعة وناعمة (قسطر) لقياس الضغط أثناء ملء المثانة ببطء ثم إفراغها. الهدف هو إعادة إنتاج أعراضك في العيادة لتحديد السبب الدقيق وتخطيط العلاج المناسب.

عن هذا الفحص

ديناميكا البول ليست فحصاً واحداً بل مجموعة فحوصات تُجرى معاً. بحسب احتياجاتك قد تشمل:

- **فحص التدفق** — تتبول في مرحاض خاص يقيس تدفق البول، ثم يتحقق الفريق من الكمية المتبقية.
- **دراسة الملاء** — تُملأ المثانة ببطء مع قياس الضغط وتسجيل ما تشعر به.
- **دراسة ضغط التدفق** — قياس الضغط أثناء التبول.
- أحياناً تُلتقط صور بالأشعة السينية في نفس الوقت (ديناميكا البول بالفديو).

يُستخدم أنبوبان رقيقان: الأول في المثانة (عبر الإحليل)، والثاني صغير جداً في المستقيم (أو المهبل) لقياس ضغط البطن، حتى يتمكن الفريق من التمييز بين ضغط المثانة والإجهاد العضلي.

هل هو آمن؟

نعم. ديناميكا البول فحص تفاعلي منخفض المخاطر. الخطر الرئيسي مرتبط بالقسطر — حرقه مؤقتة وإمكانية ضئيلة للإصابة بعدوى بولية. قد تُعطى مضاداً حيوياً. لا تتضمن أي جراحة ولا تستلزم فترة تعافٍ.

تعلم المصطلحات

ديناميكا البول

مجموعة فحوصات تقيس كيفية تخزين المثانة للبول وإفراغه.

المثانة

الكيس العضلي الذي يخزن البول حتى التبول.

القسطرة

أنبوب رقيق ناعم يُستخدم لملء المثانة وقياس الضغط.

دراسة الملاء

تقيس الضغط والإحساس أثناء امتلاء المثانة ببطء.

دراسة ضغط التدفق

تقيس الضغط أثناء التبول لتقييم إفراغ المثانة.

فحص التدفق

يقيس سرعة ونمط تدفق البول.

ديناميكا البول بالفديو

الفحص ذاته مع إضافة صور أشعة سينية لمزيد من التفاصيل.

البقايا البولية بعد التبول

كمية البول المتبقية في المثانة بعد التبول.

هل سيؤلم؟ يشعر معظم الناس بضغط وبعض الإحراج من القساطر أكثر من الألم الحقيقي. ستُطلب منك الكحة وتغيير الوضعية والتبول أثناء الفحص — يحرص الفريق على خصوصيتك ويعمل بالوتيرة المناسبة لك. يستغرق الفحص عادةً نحو 30-60 دقيقة، ويمكنك العودة إلى المنزل مباشرةً.

كيف تستعدّ (قبل الفحص)

بعد الفحص

- يمكنك العودة إلى أنشطتك الطبيعية فوراً.
- قد تشعر بحرقة خفيفة عند التبول ليوم أو نحوه. يساعد شرب الماء بكثرة في تخفيف ذلك.
- قد تلاحظ لوناً وردياً خفيفاً في البول لفترة قصيرة. هذا أمر شائع ويزول عادةً خلال يوم.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمى أو قشعريرة
- صعوبة في التبول أو عجز تام عنه
- نزيف غزير أو جلطات دموية في البول
- ألم يزداد بدلاً من أن يتحسن

- قد يُطلب منك الحضور ومثانتك ممتلئة بشكل مريح — اتّبع التعليمات المقدّمة لك.
- تناول أدويةك المعتادة، لكن اسأل عن ضرورة وقف أدوية المثانة قبل الفحص، إذ قد تؤثر في النتائج.
- لا حاجة للتخدير، لذا يمكنك عادةً قيادة سيارتك للعودة.

أخبر فريقك مسبقاً إذا كنت:

- تعاني من علامات عدوى بولية (حرقة، حمى، أو بول عكر ذو رائحة قوية) — قد يُؤجل الفحص في حالة وجود عدوى نشطة
- تتناول مميعاً للدم، أو لديك حساسية (بما فيها اللاتكس)

قد يُطلب منك تقديم عينة بول للتحقق من الخلو من العدوى قبل الفحص.

ما الذي يحدث أثناء الفحص

- 1 تتبول في مرحاض خاص بقياس تدفق البول، ويتحقق الفريق من الكمية المتبقية.
- 2 تُوضع القساطر الرفيعة بلطف — واحدة في المثانة وأخرى صغيرة في المستقيم أو المهبل.
- 3 تُملأ المثانة ببطء وأنت تُبلّغ عن أول إحساس بالامتلاء وعند الشعور بالحاح شديد؛ قد يُطلب منك الكحة أو تغيير الوضعية.
- 4 تتبول مع تسجيل الضغوط، ثم تُزال القساطر.

ثلاثة أمور تذكّرها

1. تقيس ديناميكا البول كيفية امتلاء مثانتك وإفراغها حتى يتمكن فريقك من تحديد سبب التسرب أو الإلحاح أو صعوبة الإفراغ وتخطيط العلاج المناسب.
2. التحضير بسيط: اسأل عن إيقاف أدوية المثانة، واحضر ومثانتك ممتلئة بشكل مريح إن طُلب ذلك، وأخبر فريقك عن أي علامات عدوى.
3. توقّع ضغطاً أكثر من الألم، وعُد إلى المنزل مباشرةً. حرقة خفيفة أو لون وردي في البول ليوم أمر طبيعي — اشرب الماء جيداً، واتصل بفريقك عند الحمى أو النزيف الغزير أو صعوبة التبول.